

Sotsiaaltöö professioon, tööjõu vajadus ja ressurss

Kommentaar OSKA raportile sotsiaalpoliitika vaatenurgast

Jüri Kõre, PhD

sotsiaalpoliitika lektor, Tartu Ülikool

Oma artikliga ei taha ma propageerida või kritiseerida OSKA sotsiaaltöö raportit, esiti juba seetõttu, et raporti lõppvariant polnud artikli kirjutamise ajal veel avalikult kättesaadav. Kuulsin aga OSKA sotsiaaltöö valdkonna koordinaatori Karin Jõers-Türni konverentsiettekanget ja jagan selle pinnal tekkinud muljeid. Euroopa Komisjon analüüsis käimasoleva Euroopa Liidu (EL) finantsperioodi ülesannete kavandamiseks inimressursside potentsiaali ja illusioone meil pole: tööeliste hulk hakkab lähiaastatel senisest kiiremas tempos kahanema, ähvardades ühiskondlike tulude kahanemise ja kulude (sh sotsiaalkulude) kasvuga. ELis (27 liikmesriiki) tervikuna toimub tööjõus ulatuslik kvaliteedinihe: aastaks 2030 kõrgelt haritud tööjõu hulk võrreldes 2010. aastaga kasvab 125%le baastasemest, madalalt haritud osa aga väheneb 70%le baastasemest (Peschner ja Fota 2013).

Eesti tööjõuressursi dünaamikat kirjeldavad numbrid on aga kardinaalselt teistsugused: kõrgelt haritud 20–64aastaste töötajate dünaamika on prognoosi järgi negatiivne (98%), madalalt haritud osa positiivne (110%)! See on mõtlemapanev, sest sarnaseid järeldusi lubavad teha veel vaid Läti ja Soome rahvastikustruktuuri ja hariduskorralduse lähteandmed. Pikemalt ma sel teemal ei peatu, kuid jätan õhku kaks küsimust. Kuidas mõjutab üldine nihe tööjõu hariduslikus struktuuris nende erialade (sh sotsiaaltöö) tulevikku, kus prognoositakse tööjõuvajaduse kasvu samal ajal survega töö (teenuste) kvaliteedi tõusule? Ja millist mõju

avaldab kõrgelt haritud töötajate osakaalu vähenemine Soomes Eesti tööturule? Kuna Euroopa Komisjon (2014) peab liidusisest tööjõu mobiilsust ebapiisavaks, võib eeldada samme, mis jõuliselt toetavad inimeste liikumist madalama tootlikkusega tööturgudelt kõrgemat lisandväärtust pakkuvate riikide tööturule.

Sotsiaaltöö positsioon

Hoolekanne, nii hästi või halvasti kui me seda piiritleme, on erinevate kompetentside rakendusvaldkond. Kehtivas sotsiaalhoolekande seaduses on 10–20 eri kvalifikatsiooni, mida on vaja nõuetekohaseks või tulemuslikuks hoolekandetööks. Sotsiaaltöö kompetentse saab edukalt kasutada tööks avalikus halduses, sotsiaalkindlustuses, teenuste korralduses, noorsootöös, personalitöös, kultuurilise mitmekesisuse projektide juhtimisel (arenguabi) ja mujal. OSKA aruanne hindab sotsiaaltöö haridusega inimeste potentsiaali hoopis tagasihoidlikumana, piirdudes sotsiaaltöö ja nõustamisega seotud ametikohtadega. Tõsi, eriala piire ületavat rakendust on keeruline prognoosida, kuid nii rakendatud inimesi ei saa käsitleda koolituskana.

Piiride hägususe tõttu käsitletakse teravhoiu ja hoolekande tööjõuressursi sageli ühe tervikuna. ELis kasvas nendes kahes valdkonnas rakendatud töötajate arv aastatel 2000–2009 kokku 1,25 korda: 17,2 miljonilt 21,4 miljonini (*Social Services Europe* 2012) ja seda hoolimata kriisiaastate eelarvekärbetest. Uute liikmesriikide „kasvupotentsiaali” hinnatakse teenuste ja abi vajadust silmas

pidades keskmisest kaks korda suuremaks. Paraku lisandus Eestis uusi töötajaid keskmisega võrreldes vähem (vt tabel 1, esimene rida). Esmapilgul tundub eelnev ebavajalik, sest oma rakendatuse määrame ise. Paraku oleme hoolekandes kavandanud reforme, mida osa liikmesriike on juba läbi viinud, saades tulemuseks tööjõuvajaduse kasvu. Ennetavad valdkonnapoliitikad (näiteks turvalise paindlikkuse¹ põhimõtte rakendamine, mis on seda kasutatavates riikides tõstnud tööpoliitika kulud meie vaatenurgast taevastesse kõrgustesse, 4%ni SKPst), üleminek kogukonnapõhistele teenustele jne. Olles kuulunud ja lugenud piisavalt ettekandeid ja uuringuid deinstitutsionaliseerimisest, on mind mõnigi kord hämmastanud neis esitatud tõdemus: institutsioonides töötanud inimeste rakendamine kogukonna hoolekandes on keeruline ja nõuab pikka harjutamist. Keeruline olevat muuta juba esmast hoiakut: kas peab ootama, et klient tuleks ise teenuseosutaja juurde (nagu see on institutsioonis), või läheb teenuseosutaja ise kliendi juurde kogukonda. Kui nii ongi, siis tuleks üle vaadata OSKA ekspertide hinnangutest läbikumav väide, et uued paradigmad Eesti hoolekandes mõjutavad võib-olla vajaliku tööjõu hulka, aga ei too kaasa muutusi kvalifikatsioonis.

Aastaks 2017 on ELis prognoositud vaadeldavas valdkonnas veel 5 miljonit uut töökohta. Viimaste aastate rändekriisi arvestades ma pigem usun sellesse. Kuid isegi alataituvuse korral on Eestile aastaks 2001–2020 tehtud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) prognoos võrreldes ELiga tervikuna jällegi märksa tagasihoidlikum. Tööturu võimaluste kõrval (palk ja karjäärimuster) arvestavad eestlased välismaale tööle siirdudes järjest rohkem sealse sotsiaalkaitsega.

Välismaa sotsiaalkaitse mõjutab nii ka Eesti tööturгу. Meil tuleb sellega arvestada.

Eesti sotsiaalsektori tööjõuprognosis

Järgneva arutluse aluseks on MKM arvutused, sest erinevalt teistest teadaolevatest analüüsides (Tiit 2000, ESTA ... 2012) on tegu mitmekordse pikemaks perioodiks sama metoodikaga tehtud arvutusega. Kuna MKM toetub omakorda rahvaloenduste (REL) tulemustele, kajastuvad tabelis ka need andmed.

OSKA raporti tegijad on võtnud endale suure riski. Üsna keeruline on prognoosida, kuhu suundub lähiaastatel Eesti hoolekanne. Kuigi jagub nii ametlikke (Heaolu arengukava 2016–2023, Laste ja perede arengukava 2012–2020, Aktiivsena vananemise arengukava 2013–2020, Erihoolekande arengukava aastateks 2014–2020) kui ka mitteametlikke (Eesti omastehoolduse arengukava 2013–2020) strateegilisi dokumente, on osa olulisi küsimusi vastuseta.

Toon näite. Omavalitsused hakkasid 2009. aastal lõpetama lepinguid omastehooldajatega, tuues põhjuseks perekonnaseaduses sisalduva perekonnaliikmete hoolduse kohustuse. Möödus mõni aasta ja sotsiaalministeerium otsustas suunata 11 miljonit eurot Euroopa maksumaksja raha (koos Eesti maksumaksja panusega kokku 13 miljonit) samade omavalitsuste kätte erivajaduste, toimetulekuraskuste ja hoolduskoormusega isikute tööturule aitamiseks (Meede „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” 2016), seda eelkõige sotsiaalteenuste arendamiseks. Kes omastehooldajatest saab tulevikus hooldajatoetust ja kes jääb ilma, kes saab hooldatavale tasuta koduhoolduse või hooldekodu koha, kes aga peab hoolduskohustusega perekonnaliikmena

¹ Euroopa Komisjoni määratluse kohaselt koosneb turvaline paindlikkus neljast elemendist: paindlik tööseadusandlus, tõhus sotsiaalkaitseüsteem, tulemuslik aktiivne tööpoliitika ja efektiivne elukestva õppe süsteem, vt Vörk jt 2010.

Tabel 1. Tervishoiu ja hoolekande tööjõuressurs ja tööjõuvajaduse prognoos (tuhandetes)

	2000 REL	2001 MKM	2011 MKM	2011 REL	2016 OSKA	2020 MKM	2023 MKM
Tervishoid ja hoolekanne	31,1	30,2	34,1	33,6		36,9	38,5
sh tervishoid	26,2			26,2		26,2 ¹	26,2 ¹
sh hoolekanne	4,9			7,4	9,8	10,7 ¹	12,3 ¹

¹ J. Kõre ja M. Raidma arvutus lähtudes MKM prognoosis sisalduvast eeldusest, et tervishoiu tööjõuvajadus perioodi jooksul ei kasva. Järeldus põhineb arstide arvu prognoosil (Eestis töötavaid arste 2012. a. 3800, 2023. a eri stsenaariumide kohaselt 3000–3700, vt Kiivet jt 2012).

selle eest maksma? Kas tulekul on loogiline (ja nii klientide kui teenuse osutajate jaoks sobiv ja õiglane) lõpptulemus, või pudru ja kapsad? Täna on seda võimatu ette kujutada, kuid tulemusest sõltub kogu kohaliku sotsiaaltöö korraldus.

Sellises olukorras võib riskida ainult kõige ligilähedasematel numbritel põhineva tööjõuvajaduse prognoosiga. Kui 2011.–2023. a lisandub hoolekandesse kokku 4800–5000 uut töökohta, siis kasutades rusikareeglit (20% kõrgema ja 80% madalama kvalifikatsiooniga töökohad) vajame juurde 1000 ülikooliharidusega spetsialisti.

Eelneval kümnendil oli mõningane disproportsioon sotsiaaltöötajate töökohtade dünaamika ja nende ettevalmistuse vahel. Võrdleme eelneva tabeli numbreid 2000/01.–2009/10. õppeaastatel sotsiaaltöö ja nõustamise õppekava lõpetanute arvuga. Kõigil haridustasemetel (rakendus-, bakalaureuse ja magistriõpe) sai Eesti hariduse infosüsteemi andmetel tööturg aastast keskmiselt 274 uut spetsialisti. 2010/11.–2014/15. aastate arvud on tagasihoidlikumad: 191 uut spetsialisti aastas. Aga nii esimest kui teist numbrit tuleb „kärpida” magistriõppe lõpetanute arvu võrra (vastavalt 55 ja 99 aastas), sest tööturu vaatenurgast on tegu 90% ulatuses juba rakendatud inimestega. Sel moel saadud tulemus (pakkumine) on jämedates joontes vastavuses MKM prognoosi põhjal tehtud arvutusega (nõudlusega).

Haridusstatistikat analüüsidest tõstatub loomulikult madalama kvalifikatsiooniga tööjõu ressursi küsimus. Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekava lõpetanuid kutseõppeasutustes on viimasel kümnendil olnud 107 aastas. Hooldajaid valmistavad ette neid palkavad ettevõtted, töötukassa teeb seda erakoolitusfirmade ja kutseõppeasutuste kursuste abiga, korraldatakse ka projektipõhiseid koolitusi jne. Seetõttu on mul isikuhoolduse tööjõuressursi seisu keeruline hinnata.

Vahendan Slovakkia esindaja näidet EL eesisumisperioodil, m.a 15–16. novembril Bratislavas toimunud konverentsilt „Investing in the social service workforce”. Slovakkia sotsiaal- ja hooldusala töötajatest on omal maal rakendatud 20 000, naaberriikides umbes 26 000! Välismaal töötavad nad peamiselt hooldajatena. Kui palju on hooldajana töötavaid eestlasi Soomes, seda pole meil uuritud.

Konverentsil tekitas OSKA raporti ühe koostaja Karin Jõers-Türni ettekanne poolehoidvat huvi, sest valdkonna tööjõuvajaduse arvutus on väga selge struktuuriga ja ettekande suunitlus erines üldisest tonaalsusest. Peaaegu kõigis Euroopa riikides vaevleb hoolekanne ressursipuuduses. Mõnel pool on puudu raha, teisel tööjõudu, kolmandas kohas mõlemaid. OSKA raportist vaatab Eesti osas vastu mõneti teistsugune pilt.

Millest eksperdid vaikisid

Peame tunnistama, et mitmed sotsiaaltöö

valdkonnad on meil tagasihoidlikult arenenud, seda nii sisu kui ka mahu poolest. Arenenud riikide mitmed mahukad tegevussuunad (töö immigrantidega, arenguabiga kaasnev sotsiaaltöö rassikokkupõrgete, nälja, kliimakatastroofide jms maadlevates riikides, abi inimkaubanduse ohvritele jpm) on meil olematud.

Pole võib olla tark viidata katmata teenusemahule (vajadustele), sest sellest tuletatud täiendava personalivajaduse võib alati nullida viitega rahastamise piiratusele. Kuid tegelikult on piisavalt analüüsi, mis lubavad administratiivsete ja erialaste ümberkorraldustega rahalist kokkuhoidu ehk tegelikult: raha pole põhiprobleem! Et mitte olla liiga abstraktne, viitan PricewaterhouseCoopers'i (2009) arvutustele koduõenduse-hoolduse integreerimisest saadava efekti kohta. Või võtame näiteks eakad, kellest igale viiendale peaks tervishoiuspetsialistide hooliva arvamuse kohaselt osutama ühte või teist hoolekandeteenust (vt Eesti hooldusravivõrgu arengukava 2015). See tähendab 50 000 klienti 2015. a rahvastikuandmetel. Tegelikke teenusesaajaid (eluasemeteenus, üldhooldekodu, erihooldusteenus, varjupaik, isiklik abistaja, koduteenused, mitteformaalne hooldus, osal teenustel kattuvad kliendid) oli kokku 23 000. Paberil saaks võib olla 50 000 isegi kokku, kui lisada päevakeskuste külastajad. See number lisatakse tavaliselt meie pikaajalise hoolduse klientuuri kohta Brüsselisse esitatavatele andmetele. Kuid vähemalt kolmveerand päevakeskuste ressursist on tegelikult mõeldud kogukonnakeskuse rolli täitmiseks. Ja kui institutsioon ei osuta sotsiaalteenust, siis pole seal kohta ka sotsiaalala spetsialistil. Kui tekib vajadus profiili muuta (näiteks kujundades päevakeskuse kogukonnohoolekande tugipunktiks), siis peab muutuma ka töötajate profiil. Teenuste vajaduse rahuldamise teemal on asjakohane meenutada sotsiaalhoolekandeseaduse

3. paragrahvi ja ka õiguskantsler Ülle Madise kirja 24.10.2016 „Sotsiaalteenused kohalikus omavalitsuses”: „... inimesele tuleb anda abi, mis teda aitab, ja seda nii palju, kui tema abivajaduse katmiseks vaja on.”

Üks eksperthinnang, mida julgen vaidlustada, on prognoos, et väheneb sotsiaaltöö juhtide arv. Argumentideks on toodud haldusreform ja omavalitsuste arvu vähenemine. Mariliis Raidma magistritööst (2016) selgub hoopis vastupidine tendents. 2016. a oli 40% omavalitsustes ametis vaid üks sotsiaaltöö spetsialist, 42% 2–3 ja ainult 18% 4 või rohkem (kahes omavalitsuses oli formaalselt üks sotsiaaltöötaja, kuid sisuliselt oli tegemist n-ö liitametikohtaga, sotsiaaltöötaja ülesanded kahasse muu kompetentsiga). Polnud hoolekannet korraldavat struktuuri, järelikult polnud ka juhti. Aastatel 2010–2016 toimunud liitumistega tekkinud uutest omavalitsustest (Lääne-Saare, Viljandi, Kose, Audru, Lügane, Põlva, Lääne-Nigula ja Hiiu vald), pole vaid kahel väiksemal (Lügane ja Lääne-Nigula, vähem kui 5000 elanikku) omaette sotsiaaltöö üksust, ülejäänutel on 4–6 spetsialistiga sotsiaaltöö teenistus või osakond ja loomulikult on sellel ka juhataja. Sama uuring annab veendumuse, et reformi järel kasvab lastekaitsetöötajate arv vähemalt 30 võrra. Rääkides KOVi tasandi (ainult valla ja linna asutused, arvestamata hallatavaid asutusi) sotsiaaltööst, meenutame varasemates tööjõuvajaduse hinnangutes sisalduvat viidet defitsiidile. Nimelt oli 2000. aastal võrreldes ekspertide poolt hinnatud vajadusega puudu 300, 2010. a 200 (hinnangu aluseks on 2000. a vajadus) ja 2016. a 100 töötajat (Tiit 2000).

Kuhu kaovad haritud sotsiaaltöötajad

Miks on vaatamata näiliselt suurele koolitusmahule mõnikord raske vajalikku töötajat hoolekandesse leida? Osa vastust on Slovakkia olusid kirjeldavas näites. Tean nii endisi kolleege

kui ka õpilasi, kes töötavad Soomes, kuid üldistuseks andmeid pole. Kordan üldteada asjaolusid, mis mõjutavad nii sotsiaal- kui ka hooldustöötajate kutsealast püsivust. Esiteks disproportsioon palga ja töö iseloomu vahel (suur füüsiline pinge ja emotsionaalne stress). Teiseks lühike karjääriahel ja ebaselged karjäärivõimalused. Kolmandaks valdkonna madal innovaatus (meil on see eriti terav probleem). Neil ja veel mõnedel põhjustel on tagasihoidlik erialatruudus ja suhteliselt kõrge voolavus vähemal lähemas tulevikus Eesti hoolekande paratamatus. Kas selle korvamine mõnel ajahetkel vajadust ületava kõrgharidusega töötajate koolitamisega on õige tee? See väärrib arutamist. Hetkel pole näha, et tööturg pakuks alternatiivseid lahendusi.

Sotsiaaltöötajale õpingutega antavad kompetentsid on suhteliselt universaalsed ja võimaldavad laialdast rakendust. Seda seisukohta toetab Töötukassa töötöingu statistika. Vaadeldava perioodi jooksul on valdkonna töötajate osakaal kogu Töötukassa klientuuris tõusnud (1,3%lt 2012. a

1,6%ni 2016), kuid nimieriala (sotsiaaltöö ja -nõustamine) töötajate osakaal on jäänud samale marginaalsele tasemele (0,1% kõigist töötajatest).

Pärast Bologna deklaratsiooni (1999) Euroopa sotsiaaltööhariiduses toimunud muutusi hinnates rõhutati Bratislava konverentsil, et baasteadmiste ampluaa on laienenud. Erialaoskuste kõrval pakutakse märksa rohkem majanduse ja juhtimise, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika jms teadmisi.

Tartu Ülikooli sotsiaaltöö eriala tähistab tänavu 25 aastapäeva. Rõõm on tunitada, et need teadmised on meil olnud õppekava osaks juba alates 1992. aastast. IFSW (Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon) võttis oma viimasel üldkoosolekul (03.10.2016) Soulis vastu deklaratsiooni „Sotsiaaltöö roll sotsiaalkaitse süsteemis: üldine õigus sotsiaalkaitsele”. See kinnitab samuti sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö suurenev seotust ning on üks näide kompetentsist, mille omandamist peab IFSW tulevaste sotsiaaltöötajate jaoks hädavajalikuks. **S**

Viidatud allikad

- ESTA sotsiaaltöö koolituse ja kutsequalifikatsiooni komisjon** (2012). Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate haridus. Uuringu aruanne. www.eswa.ee/file/2016/11/KOV_STjate_haridus_21.09.12.pdf. (26.01.17).
- Euroopa Komisjon** (2014). Draft joint employment report from the Commission and the Council. Brüssel: Euroopa Komisjon. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/jer2015_en.pdf. (26.01.17).
- Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord** (2016). *Riigi Teataja* I, 10.06.2016, 1.
- Kiivet A., Visk, H., Asser, T.** (2012) Eestis töötavate arstide arvu prognoos aastaks 2032. *Eesti Arst*, 91 (8): 403–412.
- Peschner, J., Fota, C.** (2013). Growth potential of EU human resources and policy implications for future economic growth. Working Paper 3. Luxembourg: European Commission.
- PricewaterhouseCoopers** (2009). Hoolduskoormuse vähendamiseks jätkusuutliku eakate hooldussüsteemi finantseerimissüsteemi väljatöötamine. Etapp III (finantseerimissüsteemi kirjeldus) ja lõppraport. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analysid/Sotsiaalvaldkond/etapp_iii_finantssusteeim.pdf (26.01.17).
- Raidma, M.** (2016). Sotsiaaltöö korraldus Eesti kohalikes omavalitsustes ja selle arenguvõimalused. Magistritöö, Tartu Ülikool.
- Social Services Europe** (2012). Job creation potential in the health and social service sector. https://eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Social_Services_Europe_-_Job_creation_potential_in_health_and_social_sector.pdf (26.01.17).

Tiit, E.-M. (2000). Sotsiaaltöötajate ja -hooldajate vajadus Eestis. Hetkeolukord ja tulevikunägemus. Tallinn: Sotsiaalministeerium.

Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2023, andmetabelid (2015). Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium www.mkm.ee/et/analused-ja-uuringud (02.02.17).

Võrk, A., Nurmel, K., Karu M., Osila, L. (2010). Sotsiaalkaitseüsteemi roll turvalise paindlikkuse kujundamisel Eestis. *Praxis Toimetised*, 2. www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2010_Sotsiaalkaitseusteemi_roll_turvalise_paindlikkuses.pdf (02.02.17).